

1 - 01- Otite Moyenne Aiguë - Pr. Raji

Bonjour, je me présente, je suis professeur Ragi, otorhinolaryngologiste et chirurgien cervicofacial. J'ai le plaisir aujourd'hui de commencer avec vous les cours en rapport avec la pathologie ORL dans le cadre de la formation des cinquièmes années des études médicales. Alors, ce premier cours concernera l'otite moyenne aiguë.

Sur le plan de la définition, c'est toute inflammation avec ou sans suppuration de la muqueuse de l'oreille moyenne, qui est une muqueuse de nature respiratoire et qui est le plus souvent secondaire à une agression ou qu'elle soit d'origine virale ou d'origine bactérienne. Cette agression d'origine virale ou bactérienne va engendrer des modifications au niveau de la fonction de la muqueuse respiratoire de l'oreille moyenne et être responsable de modifications de l'aspect otoscopique. Vous voyez là un aspect otoscopique tout à fait normal de l'oreille.

Un aspect otoscopique où on voit l'existence d'un processus inflammatoire qui touche le shrapnel et qui s'étend au niveau du manche du marteau, respectant bien sûr le reste de la membrane tympanique et bien sûr, qui peut évoluer vers un stade plus avancé vers une infection collective. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? C'est premièrement de savoir définir ce que c'est qu'une otite moyenne aiguë. Deuxièmement, c'est de rechercher les signes cliniques d'une otite moyenne aiguë et de pouvoir différencier sur le plan clinique une otite moyenne aiguë au stade congestif, au stade collecté et au stade perforé.

De savoir rechercher les complications d'une otite moyenne aiguë parce qu'il existe et en existe. De connaître les principes du traitement d'une otite moyenne aiguë globalement et bien sûr, rechercher dans le cadre d'une otite moyenne aiguë récurrente, quels sont les facteurs favorisants? Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie fréquente essentiellement chez l'enfant, mais qui peut toucher, bien sûr, tous les âges. Il n'y a pas de prédominance sexuelle.

Les garçons sont aussi bien touchés que les filles et ils prédominent le plus souvent pendant la période hivernale, au cours de laquelle les infections virales des voies respiratoires sont beaucoup plus. Comment survient cette infection? C'est à dire d'où elle va venir et comment est ce qu'elle va atteindre l'oreille moyenne? Il y a deux voies d'infection. La voie hématogène est exceptionnelle, c'est à dire le passage du germe au niveau sanguin pour atteindre la muqueuse respiratoire de la caisse du tympan.

Et bien entendu, la voie nasotympanique, c'est à dire l'infection provenant du rhinopharynx et se propageant le long de la trompe de Eustache vers la caisse du tympan. Ceci nous explique très bien, vu l'anatomie de la trompe de Eustache chez l'enfant et chez l'adulte, la fréquence de ces otites moyennes aiguës chez l'enfant, vu que la trompe de Eustache est plus horizontale et elle est bien sûr beaucoup plus courte et béante. Sur le plan microbiologique, l'otite moyenne aiguë peut être secondaire à un certain nombre de virus, essentiellement des virus qui touchent les voies respiratoires hautes, mais surtout à des bactéries qui sont différentes en fonction de l'âge de

l'apparition de cette otite moyenne aiguë.

Ces bactéries sont essentiellement représentées par l'hémophilus influenzae ou le streptococci pneumoniae quand l'enfant est âgé d'entre trois mois et cinq ans. Et lorsqu'il est âgé de moins de moins de trois mois, la bactériologie est très variable, peut être infectée par le staphylococci, le pseudomonas, l'hémophilus, le streptococci pneumoniae. Et c'est la raison pour laquelle, à cet âge là, il faut réaliser de façon systématiquement un prélèvement bactériologique par parasyntèse avant d'envisager toute antibiothérapie.

Sur le plan anatomopathologique, l'otite moyenne aiguë évolue en quatre phases. Une première phase d'hypérémie où l'infection va entraîner essentiellement une rougeur secondaire à l'hypervascularisation. C'est à ce stade là qu'on va parler d'otite congestive.

On voit que la rougeur touche le shrapnel et le manche du marteau. Un stade plus évolué, c'est la phase d'excudation et de supuration, où à l'intérieur de la caisse du tympan, on va retrouver des sécrétions purulentes qui vont faire bomber la membrane tympanique en juger par la rétraction de l'ombilique et bien sûr, la persistance de l'inflammation qui a été décrite sur la phase d'hypérémie. La phase de régression, c'est à dire la phase où la muqueuse respiratoire au niveau de la caisse du tympan va revenir à sa fonction tout à fait normale et donc, on va retrouver l'aspect tout à fait normal qu'on retrouve habituellement au cours d'une otoscopie chez un patient qui n'a aucune symptomatologie clinique.

Quel est maintenant le diagnostic positif de l'otite moyenne aiguë? Comme nous l'avons vu sur le chapitre en APAT, l'otite moyenne aiguë va évoluer en plusieurs phases et par conséquent, sur le plan clinique, nous allons être confrontés à des phases différentes aussi. Quand l'otite moyenne aiguë est congestive, la symptomatologie fonctionnelle est faite d'otalgie intense, d'une hypoacousie qui peut passer au second plan devant l'otalgie, d'une fièvre atteignant les 38 degrés et bien sûr, d'une irritabilité et troubles digestifs accompagnant le plus souvent toutes les infections respiratoires chez l'enfant. Sur le plan physique, l'otoscopie montre un tympan rosé, hyperhémie, vu ce stade d'otite congestive sur le shrapnel et sur le manche du marteau.

Et bien sûr, cet aspect là va nous attester de la phase d'otite congestive. Alors, à ce stade, on va rechercher l'existence de complications, plus particulièrement une mastoïdite. Et bien sûr, on va examiner les fosses nasales, le cavant et les sinus à la recherche d'une porte d'entrée de cette otite moyenne aiguë.

L'examen otoscopique est un examen clé parce que c'est lui qui va nous permettre de distinguer l'aspect anormal de ce qu'on va trouver sur la membrane tympanique, c'est à dire ici une otite moyenne aiguë congestive avec une inflammation sur le shrapnel et le manche, comparée à une otoscopie tout à fait normale où on voit le manche tout blanc avec un tympan gris rosé luisant, un triangle lumineux partant de l'ombilique vers l'avant. Et vers le bas. Alors, quand l'otite moyenne aiguë au stade d'otite congestive n'est pas prise en charge, il va évoluer vers l'otite collectée.

Celle-ci va se manifester sur le plan fonctionnel par une otalgie intense et insomniente avec des acouphènes lorsque l'enfant arrive à les décrire. Une hypoacousie beaucoup plus marquée par l'existence d'une collection à l'intérieur de la caisse du tympan gênant la mobilité de la membrane tympanique et de la chaîne ossiculaire et un syndrome fébrile avec une fièvre supérieure à 39 degrés. Le plus souvent, l'otoscopie va montrer un tympan rouge sans relief comme vous voyez sur la photo.

C'est un tympan qui est inflammatoire, mais on ne voit plus de relief de la chaîne ossiculaire et qui bombe par la présence de la collection à l'intérieur de la caisse du tympan jugée par la rétraction de l'ombilique. Quand cette otite collectée n'est pas prise en charge ou parfois lorsqu'elle est prise en charge tardivement, la pression sur la membrane tympanique va entraîner la rupture de cette membrane tympanique qui, le plus souvent, est secondaire à l'infection. De façon spontanée, mais parfois dans certaines situations que nous allons voir lorsqu'on va parler des indications des parasyntèses, on est amené à ouvrir la membrane tympanique, c'est à dire ce qu'on appelle la parasyntèse.

Et donc, à ce moment là, l'ouverture de cette otite moyenne aiguë va être chirurgicale. Alors, qu'est ce qu'on constate à ce moment là? On constatera la sédation rapide des symptômes chez le patient puisque les sécrétions pérulentes sont évacuées, ce qui va donner une otorée, un écoulement au niveau du conduit auditif externe. Et donc, ces symptômes vont s'amender et donc surtout l'otalgie va disparaître, ce qui va permettre à ce que l'enfant retrouve le sommeil.

Mais par contre, l'otorée va apparaître et il sera abondante, micopérulente, striée. À ce stade du diagnostic, souvent on est amené à savoir de quels germes il s'agit dans le cadre de la prise en charge du patient et ceci nous amène à parler des corrélations bactériocliniques. Alors, quels sont les éléments cliniques qui vont nous permettre de penser à un pneumocoque? C'est essentiellement lorsque la fièvre est très élevée, l'otalgie est très importante.

Quand est ce qu'on va parler et parler ou penser à un nymophilus influencé? C'est lorsque l'otite est associée à une conjonctivite pérulente. Et on pourra penser à un streptococque pétaémolytique lorsque la perforation de la membrane tympanique est précoce. Après la phase de perforation.

La symptomatologie fonctionnelle va évoluer vers la phase de réparation où la douleur va cesser le plus souvent deux à quatre jours. L'écoulement va s'arrêter entre cinq à dix jours et le tympan va se refermer au bout du quinzième jour. Ceci nous révèle bien que la prise en charge d'otite moyenne aiguë va nécessiter de la part du médecin une surveillance régulière du patient et qui va bien sûr juger de la restitution fonctionnelle de l'audition entre trois à quatre semaines.

La prise en charge thérapeutique. Est ce qu'il y a des diagnostics différentiels à l'otite moyenne aiguë? Oui, c'est d'abord l'otite séromuqueuse. On va la voir dans le cadre des otites moyennes chroniques simples.

L'otite séromuqueuse ne peut donner des otalgies qui ne sont pas très intenses, mais ils ne donnent jamais de fièvre. Et bien sûr, l'aspect otoscopique est tout à fait différent de l'otite moyenne aiguë. La méningite aiguë, c'est une inflammation d'origine infectieuse de la couche épidermique de la membrane tympanique.

Elle peut prêter à confusion avec l'otite moyenne aiguë congestive, mais cette ou bien collectée et donc. Mais dans ce cadre là, il faut savoir que le relief de la membrane tympanique sont totalement respectés. L'otite externe diffuse peut prêter à confusion avec l'otite moyenne aiguë.

La différence entre les deux est une différence déjà dans la description de l'otalgie. C'est une otalgie qui est bien sûr intense, mais qui est exacerbée par la mobilisation du pavillon de l'oreille. Comme vous le savez, la mobilisation du pavillon de l'oreille va mobiliser la partie externe du conduit auditif externe.

Et donc, si la mobilisation du pavillon de l'oreille provoque une douleur à la mobilisation, une douleur à la mobilisation, à ce moment là, il s'agirait d'une otite moyenne, une otite externe diffuse qu'on va confirmer par l'otoscopie qui va montrer un conduit auditif externe inflammatoire, mais un tympan macéré gardant ses reliefs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation à l'intérieur de la caisse du tympan. Là, ces diagnostics différentiels sont très importants à connaître parce que la prise en charge sera différente.

Quelles sont les formes cliniques de cette pathologie? Les otites moyennes aiguës seraient différentes en fonction de l'âge d'apparition et bien sûr, en fonction du terrain. Nous venons de voir que chez le nouveau né, le nourissant, la bactériologie est différente et donc ce qui peut poser des problèmes dans le cadre du diagnostic et surtout dans le cadre du prise en charge thérapeutique, l'antibiothérapie doit être corrélée à la corrélation à la au prélèvement bactériologique et ils ont la caractéristique d'être bilatéral. Chez le vieillard, le diabétique et l'immunodéprimé, l'otite moyenne aiguë prend un aspect un peu particulier de d'otite torpide.

Les formes évolutives, plus particulièrement les formes sur aiguë où le patient est diagnostiqué malheureusement au stade de complication que nous allons voir tout à l'heure et bien sûr, les formes récidivantes qui normalement devraient nous amener à rechercher de façon systématique les facteurs. Alors, quels sont ces facteurs favorisant de l'otite récidivante, c'est à dire l'otite qui guérit et qui récidive dans le temps. C'est tout d'abord les otites séromuqueuses sous jacentes qui persistent longtemps et qui favorisent la surinfection.

L'hypertrophie des végétations adénoïdiennes qui favorisent un milieu inflammatoire et infectieux au niveau du rhinopharynx quiensemenceraient de façon régulière la caisse du tympan. La vie en collectivité, plus particulièrement en crèche où la transmission des infections respiratoires est plus fréquente chez les petits enfants et aussi le tabagisme passif. Quelles sont les complications des otites moyennes aiguës? La première complication qu'on doit rechercher de façon systématique, c'est la mastoïdite.

Comment est ce qu'on doit penser à cette mastoïdite? C'est devant un tableau clinique d'otites moyennes aiguës qui s'aggrave avec l'apparition d'un œdème d'origine inflammatoire rétro auriculaire. Comme vous voyez sur cette photo, il y a une inflammation rétro auriculaire qui fait bomber la région mastoïdienne et qui soulève le papillon de l'oreille. Lorsqu'on palpe cette région, on peut provoquer une douleur vive et bien sûr, devant cette tumefaction, on recherchera de façon systématique l'existence de fluctuations qui vont signifier l'existence d'une collection au niveau de la région mastoïdienne au cadre des mastoïdites supérieures.

La paralysie faciale périphérique étant la deuxième complication qu'on peut rencontrer dans le cadre des otites moyennes aiguës. Il faut savoir qu'il survient en général au début de l'otite, comme vous le voyez chez ce petit enfant qui présente une paralysie faciale droite. C'est une diviation de la face vers le côté sein gauche lors des pleurs secondaire à une otite moyenne aiguë.

Quand on a ce type de complications, bien sûr, on ne va pas faire de l'antibiothérapie probabiliste. Il faut viser une antibiothérapie adaptée à la suite d'un prélèvement bactériologique par synthèse. Chose importante, ce qu'il faut savoir, c'est que la paralysie faciale régresse avec la régression de l'otite moyenne.

Troisième complication, c'est les labyrinthites dues à l'extension de l'infection à l'oreille interne, soit par la voie des fenêtres, soit par voie sanguine. Fort heureusement, ce sont des complications qui sont très rares. Ils vont se manifester sur le plan clinique par l'apparition de signes faisant évoquer une atteinte de l'oreille interne, à savoir les vertiges, avec un nystagmus témoignant d'un syndrome vestibulaire périphérique et d'une surdité de perception endocochléaire.

Malheureusement. Pourtant, pouvant être définitive, c'est la raison pour laquelle il faut traiter l'otite moyenne aiguë avant d'atteindre ces niveaux de complication. Et bien entendu, comme nous venons de le voir, l'antibiothérapie doit être une antibiothérapie adaptée après prélèvement bactériologique par synthèse.

Les complications méningocéphaliques sont tout d'abord la méningite autogène. D'ailleurs, vous avez un réflexe qui vous dit devant toute méningite, il faut chercher une porte d'entrée ORL et plus particulièrement une porte d'entrée au niveau de l'oreille. Ça peut être un abcès cérébral ou cérébelle ou parfois une thrombophlébite du sinus latéral.

Ce sont des situations au cours de laquelle le patient est hospitalisé avec, bien sûr, des prélèvements bactériologiques qui vont permettre, bien sûr, de cibler le germe sur le plan antibiotique. Alors, quel est maintenant le traitement de l'otite moyenne aiguë? Ce traitement a pour objectif essentiellement de soulager la douleur, parce que c'est le premier symptôme. Traiter l'infection pour, bien sûr, prévenir les complications et bien sûr, restituer l'audition.

Il est basé essentiellement sur une antibiothérapie. Cette antibiothérapie est une antibiothérapie

probabiliste, on va voir quelles sont les indications de la parasyntèse par la suite, qui chez les enfants de plus de trois mois, va se baser essentiellement sur les associations d'amoxicilline acide clavulanique. Mais en cas d'allergie, on peut passer au macrolide tel que, par exemple, l'érythromycine sulfafurazole chez les enfants de moins de six ans et bien entendu, la prestinamycine chez les enfants de plus de six ans.

Chez les nourrissons de moins de trois mois, l'antibiotérapie n'est plus une antibiotérapie probabiliste. Elle doit être adaptée après prélèvement par synthèse. Est ce qu'il y a d'autres traitements qu'on peut associer à cette antibiotérapie? Oui, à savoir des antalgiques antipéritiques.

Il faut bien sûr gérer la douleur et bien sûr la fièvre. On pourrait prescrire des anti inflammatoires stéroïdiens, c'est à dire une corticothérapie. L'objectif, c'est d'accélérer le rétablissement de la fonction de la muqueuse de la caisse du tympan et donc, par conséquent, le rétablissement de la fonction d'audition et bien sûr, diminuer le processus inflammatoire localement.

Et on peut parfois utiliser des gouttes auriculaires à visée antalgique, mais il faut se méfier de ces gouttes auriculaires à visée antalgique parce qu'il faut faire très attention à la perforation tympanique. Alors, quelles sont maintenant les indications de la parasyntèse? On peut être amené à faire une parasyntèse, c'est à dire l'ouverture de la membrane tympanique par un micro bistouri pour assurer l'évacuation du contenu de la caisse du tympan, qui est plus souvent fait par des sécrétions purulentes. Dans l'objectif essentiellement de faire un prélèvement bactériologique et étude d'antibiogrammes.

Il est fait lorsque la fièvre persiste malgré un traitement adapté. Lorsque l'otite moyenne aiguë est hyperalgique, lorsqu'il est compliqué, lorsque l'âge du patient est inférieur à trois mois, nous l'avons vu parce que les germes qui sont responsables à cet âge là de l'otite moyenne aiguë sont très diverses et lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'un terrain immunodéprimé. En conclusion, l'otite moyenne aiguë est une pathologie fréquente.

On la voit essentiellement en milieu pédiatrique, donc il touche plus l'enfant que l'adulte et le vieux. Son diagnostic est clinique, reposant essentiellement sur l'otoscopie qui va nous permettre de différencier les différents stades de l'infection. Il faut connaître dans ce cadre là à quel moment il faut faire appel à la parasyntèse avec prélèvement bactériologique.

Son traitement est un traitement médical basé sur une antibiotérapie probabiliste que nous avons vu et tout ceci, bien sûr, pour prévenir les complications. Et je vous remercie.